



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سميره سيد سعد محمد
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : الزاوية الحمراء العنوان : الزاوية الحمراء
رقم البطاقة : 25704162300123 رقم التليفون : 01115910456 تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 16-04-1957 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: ----- التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سميره سيد سعد محمد National ID: 25704162300123	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢٢/٠٤ ٢٥٧.٤١٦٢٣.٠١٢٣

ربة منزل



أنثى مسلمة متروجة
محمود عبدالرازق ابراهيم قاسم
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٤/٠٩



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

سميرة
سيد سعد محمد قاسم
ب ١٣٤ م مساكن الزاوية
الزاوية الحمراء - القاهرة

١٩٥٧/٠٤/٠٩ ٢٥٧.٤١٦٢٣.٠١٢٣

J17301598

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
دعم القرار

جهة الإصدار: فرع القاهرة

تاريخ الإصدار: 2023-1-30

إلى من يهمه الأمر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانقاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والإعاشات" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بدولاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "الأطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ذ) سمير سيد سعد محمد بطاقة رقم 23 25704162300
وطبقا إلى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفود عدم الانقاع
يتميز من الفئات غير المتفاده بالتأمين الصحي
وشكرا

الوظيف المختص

تاريخ الطابع: 2023-1-30

غادة علي

غ

الإدارة مركز تكنولوجيا المعلومات

385483



الخطاب سارو لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلى حاله تايير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID:
1- Name: *د. عبد الله بن عبد الله*
2-ID number: 25704162306123

Sex:

MDT form
7- Medical number:
Female

83122386
Old Med: 299/2023

Patient Age: 66 Y



Family history -VE
marital status MARRIED
Comorbidity DM

Phone
NRS Score
Menopausal status

0116665239
BHI
GROUP
POSTMENOPAUSAL

REASON OF MDT
Date of MDT

Breast Imaging :

Clinical data

Mets Workup :
CT CAP1/23--> MILD LONG INTERSTITIAL CHANGES
LIKELY CHRONIC INFLAMMATORY REACTION
BONE SCAN2/23-->-Ve

DX:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	IGF7 :
LT G 2 WITH FOCAL DCIS 1/23	0/8	8/8	3		
T					
IN					
M					

Sonomammography
1/23-->LT BR. SUSPICIOUS MASS E Duct ECTASIA e intraductal papillary projection.
papilloma RATHER THAN carcinomas ,,,BIRAD4 WITH SUSIPIOUS LH .

PATIENT HISTORY
PATHOLOGY REPORT 29/4/2023--> LT SM+ SLNB
FREE MARGINS,,SLN 0/4
YPT2 YPR0

MDT OUTCOME & PLAN

for adjuvant clin 4 cycles taxotere/Endoxan along with Herceptin for one year.

MEDICAL ONCOLOGY	SIGNATURE	
SURGERY	<i>[Signature]</i>	RADIOLOGY
Psychiatric	<i>[Signature]</i>	PATHOLOGY
		Nutrition

C. 27/0/17



Patient Name: Sameera Sayed Saad Mohamed Kasem	Date : 05/02/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 67 Year(s)
Medical ID: 299/2023	

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. Chest:

As compared to prior study dated 1/3/2023

- Left MRM with no sizable masses.
- Bilateral parenchymal atelectatic bands with surrounded patches of lung veiling.
- No pulmonary parenchymal masses, consolidation or cavitary lesions.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes, on non-enhanced CT basis.
- No evidence of pleural effusion, thickening or masses.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Cardiomegaly is noted.
- Dilated pulmonary artery measuring about 3.2 cm

2. Abdomen and pelvis:

- Cirrhotic liver with irregular outlines and widened interlobar fissures . No focal lesions upon non -contrast basis. No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:

- The scanned skeleton shows no lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.



Patient Name: Sameera Sayed Saad Mohamed Kasem	Date : 05/02/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 67 Year(s)
Medical ID: 299/2023	

- Dorsolumbar spondylosis.

OPINION:

Status follow up showing:

- ***Stationary course of CT chest findings.***
- ***No hepatic or osseous metastatic deposits.***

Dr. Wafaa Ali, MSc.

Dr. Amr Farouk M.D.

Request No : 13006336
Request Date : 02/03/2023
Verification Date : 29/03/2023
Financial Category : Out Patient
Department :
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Request Date :
Request Mass :

Request Specimen :
Request Mass : Simple mastectomy & SLNB specimens collected at 2/3/23

Request Examination :

Simple mastectomy specimen measured 22x18x6 cm with covering skin ellipse measured 21x15 cm. Serial cuts revealed ill defined firm mass measured 4.5x4x2 cm, located 1.5 cm from deep margin. Multiple fibrous tissue piece measured 5x2 cm enclosing 4 nodules up to 1.5x1.5 cm.

Request IHC :

Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination :

Histological type: Invasive duct carcinoma
Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): G II (3+2+1)
Lymphovascular invasion: Not detected
Ductal carcinoma in situ: extensive
Lymph node involvement: Free (0/4)
Resection Margins: Free deep margin

ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/3)
PR: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/3)
HER-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)
Ki67: 10% nuclear reaction in tumor cells

Verified by :

Dr. Marwa mahmoud

Printing Date : 29/04/2023 10:43:01

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name: الأستاذة / منيرة محمد محمود حاتم
Patient No.: 25704162300123
Ref No.: 670/2023
Sex: Female
Age: 65 Y
Referring Doc.:

Request No.: 13000556
Request Date: 02/03/2023
Verification Date: 29/04/2023
Financial Category: اورام ناز السلام - نفقة الدولة
Department: Out Patient
Registered by: marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Diagnosis:
left breast mass, simple mastectomy & SLNB specimens :
invasive duct carcinoma Grade II
near nipple and areola
free deep margins
free SLNs (0/4)
Diagnosis: pT2 . pN0
pT1c
ER: Negative (score 0/5)
PR: Negative (score 0/4)
Ki67: Positive (score 3+).
p53: Positive in 10% of tumor cells.

Prof. Gernat Abdelatty
Dr. Marwa Mahmoud
Dr. Larza Elgendy

Verified by :
Dr. Marwa mahmoud

Printing Date : 29/04/2023 10:43:01

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse

Patient Name :	الأستاذ / سمير سعيد محمد قاسم	Request No. :	13006396
Patient No. :	25704162300123	Request Date :	02/03/2023
Path No. :	670/2023	Verification Date :	22/03/2023
Sex :	Female	Financial Category :	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age :	65 Y	Department :	Out Patient
Referring Doc :		Registered by :	marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data :
Left breast mass

Nature of specimen:
Left simple mastectomy & SLNB specimens collected at 2/3/23

Gross examination:

1) Left simple mastectomy specimen measured 22x18x6 cm with covering skin ellipse measured 21x15 cm, serial cuts revealed ill defined firm mass measured 4.5x4x2 cm, located 1.5 cm from deep margin.

2)SLNB:Fibrofatty tissue piece measured 5x2 cm enclosing 4 nodules up to 1.5x1.5 cm

- Frozen section :
- Free SLNs (0/4)

Microscopic examination: :

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Lymphovascular invasion : Not detected
- Ductal carcinoma in situ: extensive
- Lymph node involvement: Free (0/4)
- Resection Margins: Free deep margin

Diagnosis:

Left breast mass, simple mastectomy & SLNB specimens :

- Invasive duct carcinoma Grade II
- Free nipple and areola
- Free deep margins
- Free SLNs (0/4)

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 22/03/2023 12:37:56

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name : الأستاذة / سميرة سيد محمد قاسم	Request No. : 13006336
Patient No. : 25704162300123	Request Date : 02/03/2023
Path No. : 670/2023	Verification Date : 22/03/2023
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 65 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

-Stage : pT2 , pN0

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Marwa Mahmoud

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 22/03/2023 12:37:56

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name: Samira Sayed Saad Mohammad

Patient ID:10210123023535

DT:2/2/2023 12:54:11 PM

د. أحمد مصطفى الحوي

Tc^{99m} MDP whole body bone scan

History:

- 66-year-old patient , known case of left breast didn't receive treatment.

Technique:

Whole body anterior and posterior blood-pool and delayed 3 hours scans were taken after IV injection of 20 mCi of Tc^{99m} MDP.

Findings:

Suboptimal study due to high BMI.

a)Bone lesions:

- Homogenous tracer distribution through the surveyed skeleton
- There are no osseous lesions suspicious for metastatic disease
- Bilateral degenerative changes of both shoulders and knees.

b)Other findings:

- Soft tissue contours are unremarkable .
- Both kidneys are visualized.

Impression:

- The surveyed skeleton is keeping free from metastatic osseous deposits.

Mahmoud Mustafa, MSc.

Amr A Hanafy, MD

Dr. Amr A Hanafy, MSc



X-Ray	Ultrasound	Doppler	Digit. I Rad.	C.T.	MRI	Mammography
-------	------------	---------	---------------	------	-----	-------------

Patient Name: Mrs. SAMIRA SAYED

Date: Wednesday, January 25, 2023

Bilateral Sono- Moammography

- The breast composition is predominantly fatty.
- Normal skin and the subcutaneous tissues lines.
- Left retroareolar outer quadrant mass is noted with microcalcification
- Two adjacent opacity seen at upper inner quadrant
- Retroareolar ductectasia
- Complementary US shows:
 - Left breast show mass lesion at upper outer quadrant measures about 20x9 mm with spiculation and dots of calcification
 - Another adjacent lesion measures 13x10 mm
 - Left breast two cysts are noted measures 11x8 mm and 8x6.5 mm with turbid content
 - Dilated ducts with intraductal papillar projection forming soft tissue component with internal vascularity
 - Left axillary lymph nodes are note with oval shaped an thickened cortex the largest 11x7.5 mm
 - Normal right breast

Conclusion:

- Left breast suspicious mass lesion with ductectasia and Intraductal papillary projection / papilloma rthier than carcinoma for MRI BI-RAD 4 with associated lymph nodes

WITH MY BEST REGARDS
Dr. MOHAMED SHABEN

Radiology Department